جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : شربات محمود محمد دردح
المحافظة : الغربيه **الحي / المدينة :** شرشابه **العنوان :** 0.
رقم البطاقة : 25108071600408 **رقم التليفون :** 01021321578 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 11-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 07-08-1951 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

المقر بما فيه
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: شربات محمود محمد دردح
National ID: 25108071600408



تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

[[DOCTYPE:IHC]]
Immunohistochemistry

Patient Name	الأستاذه / شربات محمود محمد دردح	Request No.	13002823
Patient No.	25108071600408	Request Date	23/09/2024
Path No.	3586/24	Verification Date	13/10/2024
Sex	Female	Financial Category	اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	73 Y	Department	Out Patient
Referreing Doc.			
		Registered by	.marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, week, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

* Scoring system: "Her2"

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations, 2013.IHC 0: as defined by no staining observed or membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within < 10%of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is incomplete, intense < 10% of tumor cells.

Signature
Prof. Dr. Gamal Abdelatty.
Dr. Duaa Mohamed.

Verified by :

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

[[DOCTYPE:IHC]]
Immunohistochemistry

Patient Name	: الأستاذه / شربات محمود محمد دردح	Request No.	: 13002823
Patient No.	: 25108071600408	Request Date	: 23/09/2024
Path No.	: 3586/24	Verification Date	: 13/10/2024
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 73 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc.	:	IHC No.	:
		Registered by	: .marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data: Left breast retroareolar mass.
Nature of Specimen: Tru-cut biopsy.

Technique:
Sections were prepared from the paraffin block, processed in Bench Mark ULTRA machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using ultra view HRP DAB as chromogen and Hematoxylin as counter stain. The sections treated against:
ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Results:
IPT (Positive control showed appropriate reactivity):
ER: Moderate nuclear reaction in 70% of tumor cells (score 7/8).
PR: Moderate nuclear reaction in 50% of tumor cells (score 6/8).
Her2: No membrane reaction in tumor cells (score 0).
Ki67: 25% nuclear reaction of tumor cells.

Conclusion:
Left breast retro-areolar mass, Tru-cut biopsy:
Invasive mammary carcinoma, Grade II.
IPT:
ER: Positive (score 7/8).
PR: Positive (score 6/8).
Her2: Negative (score 0).
Ki67: Positive in 25% of tumor cells.
E-Cadherin in processing.

Scoring system: "ER, PR"

Verified by :

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

[[DOCTYPE:ULTRASOUND]]
ultrasound

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصـــــحة والسكـــان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Date : 15/10/2024	Patient Name: Sharbat Mahmoud Mohamed Drdh
Age : 73 Year(s)	Exam : ultrasound ABDOMEN& PELVIS
Pat. ID: 90729	Medical ID: 3538/2024

ABDOMINO-PELVIC ULTRASOUND EXAMINATION REVEALED:

Liver: -

- *Enlarged in size (about 18 cm at the right MCL), smooth outline, bright echopattern. No intra hepatic biliary radicle dilatation.*
- *Portal vein is not dilated and patent .*

Gall Bladder: -

- *Average size, normal wall thickness, no stones.*
- *CBD is not dilated.*

Spleen: -

- *Average size (About 10 cm), displaying homogenous echopattern.*

Kidneys: -

Are of normal size and site , normal echogenicity , no stone or backpressure changes , no solid or cystic lesion.

-Para-aortic and pancreatic area: no gross lesion

***URINARY BLADDER**: Normal filling. Normal wall thickness, no stones or diverticulae or solid lesion detected.*

***Uterus: -**: anti-verted, bulky uterus. Average Endometrial thickness, no focal lesions*

No free fluid in the Douglas pouch.

Opinion:

Bright hepatomegaly.
Bulky uterus

Best Regards,
Dr Dina Gaber , FEBR

Not Approved

[[DOCTYPE:CT_SCAN]]
CT Scan

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصـــــحة والسكـــان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Sharbat Mahmoud Mohamed Drdh	Date : 15/10/2024
Exam : C.T CHEST	Age : 73 Year(s)
Medical ID: 3238/2024	Pat. ID: 90729

- Enlarged bilateral inguinal lymph nodes, the largest measures about 1 cm 1.4 x 2 cm.
- No ascites.
- Few vertebral bodies predominatly lytic lesions are seen affecting D6, D9 and L2 vertebral bodies.

Opinion:

- **Reported case of left breast cancer revealed:**
- **Two middle lobe small pulmonary nodules. For follow-up.**
- **Few vertebral bodies predominatly lytic lesions. For bone scan correlation.**
- **No sizable hepatic deposits on non-contrast basis.**

Dr. Ali Elsisy, MSc.

Signature Prof. Menna Tallah Hanafy

28/10/2024 05:26 م

[[DOCTYPE:CT_SCAN]]
CT Scan

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصـــــحة والسكـــان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Sharbat Mahmoud Mohamed Drdh	Date : 15/10/2024
Exam : C.T CHEST	Age : 73 Year(s)
Medical ID: 3238/2024	Pat. ID: 90729

NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS:

- **Reported case of left breast cancer.**

I Chest:

- *The left breast shows heterogeneous parenchyma and edema pattern with diffuse skin thickening. Enlarged axillary level I and II lymph nodes, the largest at level I measures about 1.3 x 2.3 cm.*
- Two small middle lobe pulmonary nodules, the largest measures about 4 mm.
- Elevated left hemi diaphragmatic copula with overlying atelectatic bands.
- No pulmonary areas of ground glass attenuation, consolidation or cavitary lesions.
- No CT evidence of pathological mediastinal lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collection, pleural thickening or masses.
- Cardiomegaly.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is enlarged showing homogenous parenchymal attenaution. No sizable focal lesions on non-contrast basis.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal non contrast CT appearance of the spleen, pancreas, kidneys and suprarenals glands.
- Averagely filled urinary blabdder showing no sizable diverticular outpouching.
- Lobulated posterior aspect of the uterine body, For US correlation.
- No pathological abdominal or pelvic lymph node enlargement.

Women's Health Outreach Program

Name: Sharabat Mahmoud Mohamed Date: 22/09/2024

Bilateral limited Digital Mammography and high resolution ultrasound examination

Clinical summary: 73 years old female patient bedridden and difficulty to complete full mammography study (Only CC views were taken) complaining from left breast palpable lump

Technique

Medio-lateral oblique and CC views High resolution ultrasound

Left breast

- (ACR density B).
- The left breast shows anterior/middle 1/3s locally advanced malignant process inform of large retroareaolar ill-defined malignant dense mass lesion measuring about 6.0 x 5.9 cm at its maximum diameters associated with architectural distortion and causing nipple retraction with overlying skin thickening.
- **Ultrasound demonstrated** locally advanced malignant process inform of large retroareaolar ill-defined malignant hypoechoic mass lesion measuring about 5.6 x 5.5 cm located at 12-1° clock position and associated with parenchymal distortion and causing nipple retraction with overlying skin thickening reaching up to 5 mm.
- Enlarged axillary lymph nodes with thickened cortex level I, II and III. One of them on the level I shows effaced hilum and globular shaped with irregular margins likely extracapsular extension measures about 12.3 x 11.5 mm.

Right breast

- (ACR density B).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of microcalcifications.
- **Ultrasound demonstrated** no solid or cystic masses.
- Normal skin/nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

- **Left breast (BIRADS 5): Left locally advanced retroareaolar malignant process as described with ipsilateral pathological axillary lymph nodes. Tru cut biopsy was done on the same day for histopathological correlation**
- **Right breast (BIRADS 2): Normal study.**

Best regards,
Dr. Hedaya Nour, MD

مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

الست المصرية هي صحة مصر

MDT FORM 4/11/2024 G C

Name	[illegible]	MRN	٤٥١٠٨٧١٦٠٠٤١
		ID	٢٠٢٨ / ٥٠٤٤
Age	٧٣ سنة	Phone	٠١٠٢٧٢٢١٥٧٥
Menopausal status	Post	Marital status	Married
NRS SCORE		Family history	C-10
BMI		REASON OF MDT	New
CO morbidity	C-1 DVT		

Clinical Data

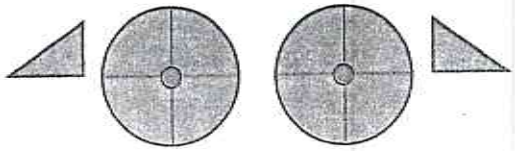
BX: Rt Brst IDC II

ER:	PR:	HER 2:	Ki67:
7/8	6/8	0	25%

Sonomammography: Locally Advanced Rt Brst Ca
Rt Br Mass 5,6 x 5,5 Cm at 12-1 clock
& Rt axillary LNs — bulky ++

Mets Workup:
2 Metastatic Lesions Suspected
Rt Hilar Enlarged Lymphatic ??

R L



TNM
C 4/3 0

Recommendations:

Bone Scan

MDT OUTCOME & PLAN

in view of poor PS & age & Non Compliance for upfront Lt MRM
Femara + Zometa

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
		Rania			

[[DOCTYPE:ULTRASOUND]]
ultrasound

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصـــــحة والسكـــان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Date : 10/12/2024	Patient Name: Sharbat Mahmoud Mohamed Drdh
Age : 73 Year(s)	Exam : sufer licial u/s
Pat. ID: 90729	Medical ID: 3538/2024

SUPERFACIAL ULTRASONOGRAPHY OF LEFT CHEST WALL:

INDICATION:

Left chest wall redness

Left MRM 1.5 month ago

REPORT

- post operative changes in the form of skin thickening measuring about 9mm, echogenic parenchyma, subcutaneous and interstitial edema
- hypoechoic seroma measuring about 3 cm as well as hypoechoic collection with turbid content measuring 6 cm mounting to abscess formation

CONCLUSION:

picture suggesting of inflammatory process with seroma and mounting to abscess formation for follow up

Yours truly

Dr. Dina GABER ,FEBR

Not Approved

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



شربات
محمود محمد دردح
٢١ش ابوعمرو السوكنى ش القناية
بولاق الدكرور - الجيزه

٢٥١٠٨٠٧١٦٠٠٤٠٨

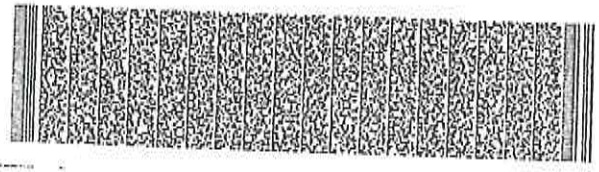
IJ8527575



٢٥١٠٨٠٧١٦٠٠٤٠٨ ٢٠٢٠/٠٣
رية منزل

انثى مسيحية متزوجة
محمد مرسى منصور سراج
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٧/٠٣/٢٠

١



محمد ذكى
مصطفى
مصطفى
ذكى

National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]